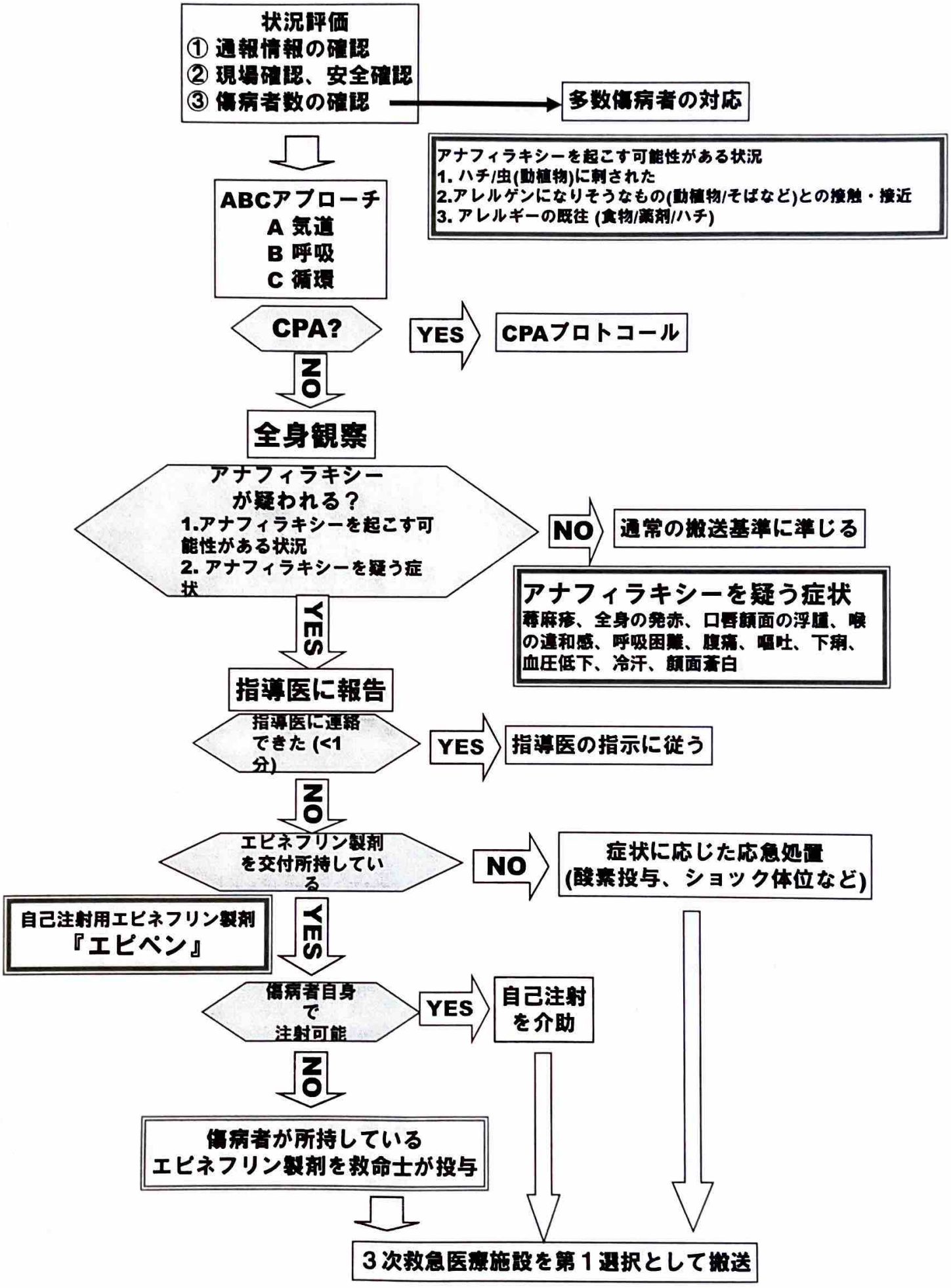
アナフィラキシーに対するエピネフリン製剤投与プロトコール

BANDO-MC協議会
指示指導部会
Vre. 190701



アナフィラキシーに対するエピネフリン製剤投与プロトコール

指導医のOnline-Medical Controlの指針

1. 救命士は『エピペン』(アナフィラキシーによる自己注射用エピネフリン製剤)を次の条件で患者に投与することができる (救命士以外の救急隊は投与できない。本人に処方されているエピペン以外のエピネフリン製剤は投与できない)
   a) 患者が処方された『エピペン』を所持している
   b) アナフィラキシーによる症状と判断した
   c) 本人が打つことができない
   d) BANDO-MCでは指導医の指示が得られれば指示に従うが、指導医の連絡がすぐに(1分以内)とれなければ現場で独自の判断で上記実施できる

2. 現場でアナフィラキシーの症状を判断することは容易でないので、BANDO-MCでは即答可能なOnline-MCが得られれば指導医の判断に従うこととした

3. アナフィラキシーを疑う状況としてプロトコールでは次の3点を上げている
   a) ハチ/虫(動植物)に刺された
   b) アレルゲンになりそうなもの (動植物/そばなど) との接触、接近
   c) アレルギーの既往 (食物/薬剤/ハチ)

4. アナフィラキシー症状として、
   蕁麻疹、全身の発赤、口唇顔面の浮腫、喉の違和感、呼吸困難、腹痛、嘔吐、下痢、血圧低下、冷汗、顔面蒼白

5. 『エピペン』は1回に0.3mgが筋注される（小児には体重に応じて0.15mg又は0.3mg製剤）
   アナフィラキシーで起こる喉頭浮腫、ショック(血管拡張による)は緊急を要する。アナフィラキシーが明らかで、現場にエピペンがあれば投与を指示してよいと思われる。遅れると搬送中にCPAとなることがある。一方、呼吸困難や腹痛、嘔吐などの症状はアナフィラキシーによるものではないこともあり得る。Online-MCでは、救命士からの報告により指導医が判断するものとする。

6. アナフィラキシーを疑った場合、『エピペン』投与の有無に係わらず、3次救急医療施設を病院選定の第1選択とする。

7. 『エピペン』投与例(自己/救命士の投与に係わらず)は、すべて検証会議に提出する

救急救命士のアナフィラキシーに対する対応指針

1. アナフィラキシーで起こる喉頭浮腫、ショック（血管拡張による）は緊急を要することから、119番入電からアナフィラキシーの初期症状の可能性があればエピペンが処方されているかを確認し、処方されていれば早期に対応するように誘導することが求められる。

   a)通報者が本人または家族の場合、医師から受けている指示に従って対応させ、初期症状のあるうちにエピペンを使用できるよう促す。
   b)通報者が教師で児童生徒に対する場合、「学校アレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に従って対応させ、初期症状のあるうちにエピペンを使用できるよう促す。
   c)傷病者の状態を注意深く見守り、反応、呼吸がなくなったらCPRを行うよう口頭指導する。

2. アナフィラキシーを疑う状況及びアナフィラキシー症状としては、指導医のOnline-Medical Controlの指針に同じ。